

Contrarreferencia y coordinación interdisciplinaria

Procedimiento | Alcance base: fisioterapia | Estado: propuesta para adopción

1. Objetivo y resultado esperado

Incorporar recomendaciones de otros servicios y mantener un plan coherente y seguro.

2. Alcance y condiciones de uso

Usuarios atendidos en más de un servicio, con derivación, cirugía, enfermedad crónica o técnica especializada.

3. Responsabilidades por rol

Rol	Responsabilidad
Fisioterapeuta	Identificar necesidad y urgencia y realizar entrega clínica.
Apoyo real	Gestionar comunicación y documentos sin alterar la decisión clínica.
Responsable de continuidad	Confirmar directorio, recepción y seguimiento posible.

4. Recursos y preparación

Mantener documento vigente, responsables reales, recursos de la actividad y soportes del emisor o fabricante pertinentes. Antes de ejecutar comprobar disponibilidad y seguridad; si falta un recurso crítico, controlar el riesgo y registrar suspensión o alternativa.

Secuencia operativa y decisiones

El orden se adapta al episodio sin omitir los controles de seguridad. Las técnicas y parámetros concretos se definen por competencia, evidencia y fabricante; no se completan con valores de ejemplo.

1. Solicitar con autorización la información pertinente y verificar identidad, emisor, fecha

Solicitar con autorización la información pertinente y verificar identidad, emisor, fecha y recomendaciones. No aceptar una instrucción anónima como autorización clínica.

2. Distinguir diagnóstico médico, restricciones y plan fisioterapéutico; aclarar contradicciones

Distinguir diagnóstico médico, restricciones y plan fisioterapéutico; aclarar contradicciones con el emisor cuando afectan seguridad, carga o técnica.

3. Actualizar objetivos, recursos y precauciones y explicar cambios al paciente

Actualizar objetivos, recursos y precauciones y explicar cambios al paciente. No aplicar una técnica incompatible con estado clínico solo por existir remisión.

4. Registrar comunicación entre profesionales y decisiones con fecha, participantes y alcance

Registrar comunicación entre profesionales y decisiones con fecha, participantes y alcance. Mantener reserva y compartir solo datos necesarios por medio protegido.

5. Si no llega respuesta y el riesgo es significativo, limitar o aplazar actividad insegura y

Si no llega respuesta y el riesgo es significativo, limitar o aplazar actividad insegura y orientar atención pertinente, documentando la razón.

6. Cerrar ciclo de referencia con resultado recibido, conducta y seguimiento

Cerrar ciclo de referencia con resultado recibido, conducta y seguimiento. Evaluar demoras y fallas de comunicación para mejorar continuidad.

Control, frecuencia y corrección

5. Verificación de la ejecución

Coordinación trazable.

Autonomía y límites profesionales respetados.

Información necesaria y protegida.

Momento	Comprobación y conducta
Antes	Verificar alcance, recurso y condición de uso descritos. Resolver discrepancias antes de comenzar; documentar aplazamiento cuando no es seguro.
Durante	Seguir los pasos de este documento y registrar modificaciones, novedades y actuaciones reales. Detener ante los criterios de riesgo del proceso.
Después	Comprobar resultado, integridad, limpieza o continuidad según proceso. Vincular registro y autor, sin dar por cumplida una tarea no observada.
Ante hallazgo	Contener el riesgo, describir causa, asignar acción y comprobar eficacia. Mantener abierto el pendiente mientras no exista evidencia de cierre.

6. Registro, conservación y seguimiento

Utilizar la ficha o formato asociado y conservar fecha, episodio, ejecutor y soporte. Los registros clínicos se incorporan a la historia reservada; documentos laborales y administrativos tienen acceso según su finalidad. Reproducir páginas de registro cuando se necesita espacio, sin condensar la información clínica ni registrar valores supuestos.

7. Aplicación normativa específica

11.1.7 y 11.3.1.29-30: para terapias el criterio específico indica no aplica. Se conserva referencia, emergencia y continuidad del 11.1.5.17; no imponer contratos de red universales.

8. Adopción y revisión

Completar responsables y condiciones de sede, leer referencias y manuales íntegros, validar el proceso y socializarlo. Registrar versión adoptada y autenticación; revisar ante cambio de norma, producto, equipo, técnica o hallazgo y en el ciclo local anual. Frecuencias y metas locales de esta edición no se presentan como exigencias legales universales.

Ficha de aplicación y referencias

Registro vacío para reproducir. Completar solo con hechos reales; identificar el documento o expediente al que pertenece. No incluye nombre, logo ni firmas preincorporadas.

Paciente	
Emisor y fecha	
Documento recibido	
Recomendación y restricción	
Duda o contradicción	
Comunicación	
Plan actualizado	
Información al paciente	
Seguimiento	
Autor	

Fuentes y límites

Habilitación

Resolución 3100 de 2019 y modificaciones vigentes; manual, criterios generales 11.1 y servicio de terapias 11.3.1. Resolución 2080 de 2026, artículo 1: revocatoria integral de 1732 de 2026; no se utiliza su manual como exigencia vigente.

https://normograma.supersalud.gov.co/compilacion/docs/resolucion_minsaludps_3100_2019.htm

Historia clínica

Resolución 1995 de 1999, artículos 3-5 y 11-14: registro, autoría, anexos, custodia y acceso. Resolución 839 de 2017, artículo 3: retención general mínima de 15 años y reglas especiales; el archivo no se elimina automáticamente al vencer un plazo.

<https://minsalud.gov.co/ihce/Paginas/Normatividad.aspx>

Ejercicio profesional

Ley 528 de 1999, artículos 1-3 y 27, principios, competencias y consentimiento previo. El contenido exige evaluación integral y fundamento científico; no garantiza resultados ni amplía competencias por tener un formato.

<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=66199>

Aprobó

Eliana Milena Pardo Ríos

TP 60576